

Communication inter-ventriculaire (CIV)

Pr RABEARIVONY Nirina
Cardiologue

Introduction

- **Définition:**
 - **Déhiscence du SIV entraînant une communication $\pm$ large entre les 2 ventricules à l'origine d'un shunt G-D**
- **Epidémiologie:**
 - **la plus fréquente des cardiopathies congénitales (20%)**

I) Physiopathologie

- Shunt G-D à l'étage ventriculaire → ↗ Q° pulmonaire
→ surcharge volumétrique cavités G
- Débit du shunt dépend de taille CIV et résistances vascul. pulmonaires
- Ce shunt peut s'accompagner d'HTAP
 - HTAP d'hyperdébit
 - HTAP fixées (par ↗ résistances artériolaires pulm.)

II) Anomalo-pathologie

II.1- CIV hautes (membraneuses)

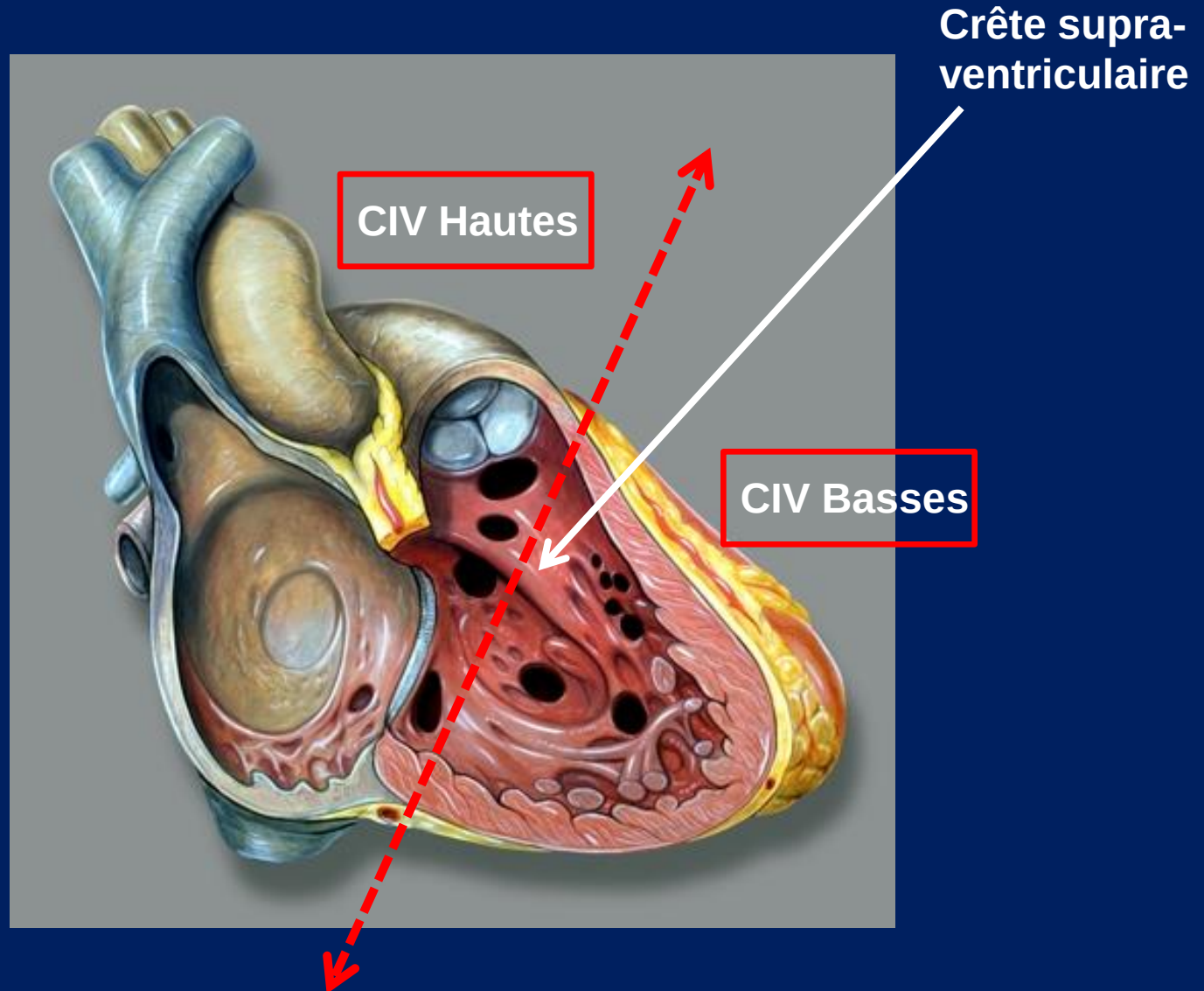
- les plus fréquentes
- au niveau de la zone du septum membraneux
- plusieurs type selon topographies:
 - **CIV hautes antérieures** (au dessus de la crête supra-ventriculaire, près des valves pulm.)
 - **CIV hautes moyennes** (au dessous de la crête supra-V)
 - **CIV hautes postérieures**

II) Anatomo-pathologie

II.2- CIV basses (musculaires)

- siègent en un point quelconque de la partie basse du SIV
- unique ou multiples

II) Anatomico-pathologie



II) Diagnostic

- **Sévérité du tableau clinique dépend de:**
 - **taille de la CIV**
 - **existence ou non d'obstacle sur la voie pulmonaire**
 - **degré d'élévation des résistances artériolaires pulmonaires**
- ➔ **différents tableaux cliniques de gravité très variable**

II) Diagnostic

II.1- CIV du groupe I (**Maladie de Roger**) = CIV à petit shunt

II.11- Clinique

II.111- SF: latente

II.112- SP:

→ souffle intense

- holosystolique
- mésocardiaque
- irradiant en rayons de roue
- avec frémissement palpatoire

« beaucoup de bruit pour rien ! »

II) Diagnostic

II.1- CIV du groupe I (**Maladie de Roger**) = CIV à petit shunt

II.12- Radiographie et ECG

- Normaux

II.13- Pronostic

- bénin

- fermeture spontanée fréquente dans la 1^{ère} enfance (10%)

II.14- Endocardite d'Osler

II) Diagnostic

II.1- CIV du groupe I (**Maladie de Roger**) = CIV à petit shunt

II.12- Radiographie et ECG

- Normaux

II.13- Pronostic

- bénin

- fermeture spontanée fréquente dans la 1^{ère} enfance (10%)

II.14- Endocardite d'Osler

II) Diagnostic

II.2- CIV du groupe II (**CIV grave**) = CIV à gros shunt

II.21- Clinique

II.211- SF:

- nourrisson +++
- retard staturo-pondéral
- polypnée avec tirage sus-sternal
- infections broncho-pulm fréquentes et trainantes

II.212- SP:

- inspection:
 - ➔ « **Thorax de Davies** »
 - voussure ant, haut située
 - dépressions sous-mammaires

II) Diagnostic

II.2- CIV du groupe II (**CIV grave**) = CIV à gros shunt

II.21- Clinique

II.212- SP:

- palpation:

→ choc apexien violent, étalé
signe de Harzer
hépatomégalie
turgescence veines jugulaires

- auscultation:

→ souffle systolique mésocardiaque

II) Diagnostic

II.2- CIV du groupe II (**CIV grave**) = CIV à gros shunt

II.22- Radiographie

- cardiomégalie
- arc moyen rectiligne ou convexe
- AP larges avec hypervascularisation pulm. franche

II.23- ECG

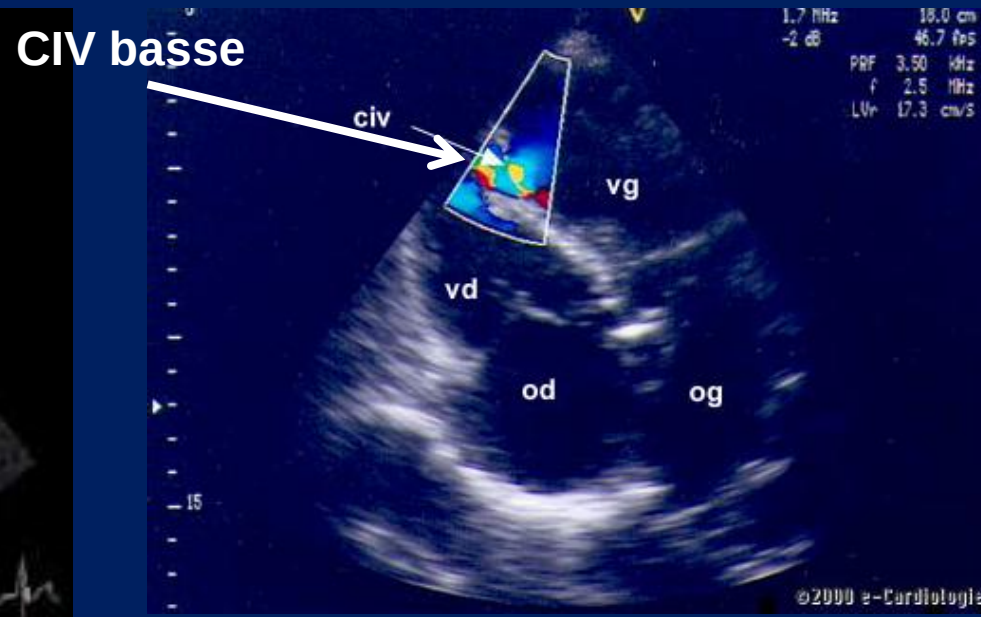
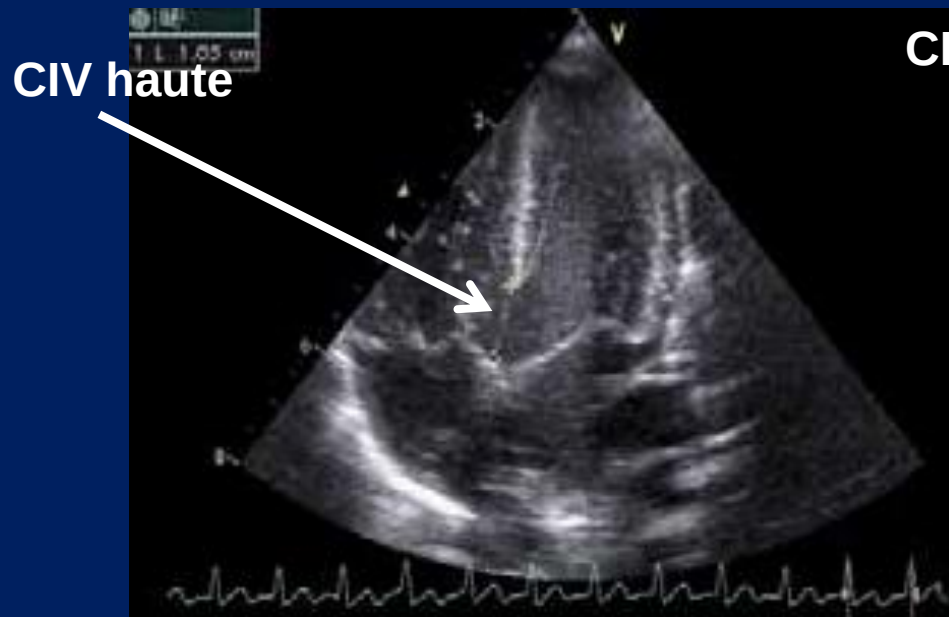
- HAG
- HVG
- HVD

II) Diagnostic

II.2- CIV du groupe II (**CIV grave**) = CIV à gros shunt

II.23- Echodoppler cardiaque

- met en évidence le défaut septal et son siège
- précise le degré de dilatation et d'hypertrophie des cavités
- évalue les pressions pulmonaires (HTAP ?)



II) Diagnostic

II.2- CIV du groupe II (**CIV grave**) = CIV à gros shunt

II.24- Cathétérisme cardiaque

- révèle l'HTAP
- permet de distinguer deux sous-types
 - CIV II a
 - CIV II b

II.25- Pronostic

- absence d'intervention → les lésions artériolaires pulm s'installent et deviennent irréversibles → évolution vers CIV III
- ces nourrissons meurent dans un tableau d'IC sévère

II) Diagnostic

II.3- CIV du groupe III (**Syndrome d'Eisenmenger**)

- rare chez le nourrisson
- souvent découvert chez le grand enfant
- mode évolutif du CIV II
(CIV + HTAP / artériolite pulm)
- peut évoluer encore pendant plusieurs décennies
- diminution du shunt G-D et amélioration paradoxal de l'enfant

II) Diagnostic

II.4- CIV du groupe IV (CIV à poumons protégés)

- peut se voir à tout âge
- souvent découvert après 2 ans en raison de leur bonne tolérance
- CIV + sténose pulmonaire infundibulaire

II) Diagnostic

Classification physiopathologique des CIV

CIV I	Mdie de Roger	PAP normale	CIV à petit shunt
CIV II	$QP/QS > 2$	a : PAP < 2/3 Pao b : PAP > 2/3 Pao	CIV à gros shunt
CIV III	$QP/QS \leq 1$	PAP = Pao	Syndrome d'Eisenmenger
CIV IV	$QP/QS > 2$	Gradient VD-AP > 25 mmHg	CIV à poumons protégés